

· 临证经验 ·

以SAPHO综合征为例探讨多系统复杂疾病的 中医系统诊疗思路与方法

张海蓉, 孙霄, 孙一珂, 祝广钦, 胡孙林, 马淑然

(北京中医药大学, 北京 100029)

摘要: SAPHO综合征是一种自身免疫系统疾病, 以皮肤、骨骼病变为主, 伴随身体多器官、组织病理损伤, 现代医学的发病机制尚不明确, 治疗仍以控制症状为主, 根治手段有待进一步探索。针对多系统同时病变的复杂病机, 中医诊疗注重人体系统的开放性和整体性, 关注病变组织、器官、脏腑之间的功能联系, 以调整机体的有序稳定为最终目标, 这与系统科学具有深刻的一致性。文章以SAPHO综合征为例, 将系统论原理与中医学玄府理论相结合, 阐释皮-脉-筋骨病机共性, 提出玄府郁闭, 积熵为病的关键病机和透玄排熵以调序的治疗大法, 结合系统科学阐述中医病机与治法的科学性, 为SAPHO综合征等多系统病变的复杂性疾病的诊治提供新思路。

关键词: SAPHO综合征; 系统科学; 中医; 玄府; 熵病; 耗散结构

Discussion on the systematic diagnosis and treatment in multi-system complex diseases with SAPHO syndrome as an example

ZHANG Hairong, SUN Xiao, SUN Yike, ZHU Guangqin, HU Sunlin, MA Shuran

(Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 100029, China)

Abstract: SAPHO syndrome is an autoimmune disease, mainly characterized by skin and bone lesions accompanied by multiple organs and histopathological injuries. The pathogenesis of SAPHO syndrome in modern medicine is unclear, and the treatment is still to control the symptoms, which needs further exploration. For the complex pathogenesis of simultaneous pathological changes in multiple systems, traditional Chinese medicine (TCM) diagnosis and treatment focuses on the openness and integrity of the human body system, the functional relationship between diseased tissues, organs and viscera, and takes the adjustment of the order and stability of the body as the ultimate goal, which has a profound consistency with systems science. Taking SAPHO syndrome as an example, this paper combined the principle of system theory with the theory of Xuanfu in TCM, and elucidated the common characteristics of the skin-blood vessel-muscles and bones. We proposed that the key pathogenesis of the disease is the stagnation of Xuanfu and the increase of entropy, as well as the key treatment of the disorder through the arrangement of entropy. Combined with systems science, this paper discussed the scientific nature of pathogenesis and treatment in TCM, and provided new ideas for the diagnosis and treatment of complex diseases with multiple system diseases such as SAPHO syndrome.

Keywords: SAPHO syndrome; Systems science; Traditional Chinese medicine; Xuanfu; Entropy disease; Dissipative structures

SAPHO综合征是一种累及皮肤、滑膜、筋骨和关节的多系统自身免疫疾病, 临床症状以滑膜炎、痤疮、脓疱病、骨肥厚、骨炎为主要症状^[1], 可遍及全身皮肤骨骼, 起病症状复杂多样, 易被误诊、漏诊, 且疾病反复发作, 迁延难愈。目前该疾病的发

病机制研究尚不完善, 现代医学的治疗以缓解症状为主, 常以非甾体抗炎药、抗生素、抗风湿药和生物制剂的联合应用^[2], 但治疗效果个体差异性较大, 难见多系统同时获效^[3], 治疗方式有待进一步探索研究。

基金资助: 北京中医药大学横向科研项目 (No.BUCM-2022-JS-ZX-005)

通信作者: 马淑然, 北京市朝阳区北三环东路11号北京中医药大学基础医学院313室, 邮编: 100029, 电话: 010-64286491

E-mail: mashuran64@sina.com

中医古籍中未见SAPHO综合征的明确记录,因其多累及骨关节而表现出疼痛、关节变形、活动受限等症状,目前中医多将SAPHO归属“五体痹”中的“骨痹”,治疗上以祛邪活络止痛为主^[4]。但骨痹的病变集中于骨骼,忽视了皮肤损害这一主要病理表现,不能涵盖该疾病的全部病理特征,将皮肤与骨骼病变机制分开而论,不符合中医整体观念的要求,也不利于疾病的诊断与治疗。多系统疾病的病机往往更加复杂,其诊断与治疗更应从系统间的功能联系入手,以玄府为媒介,以中医系统论为方法论,建立起跨越组织、脏腑、器官的整体病机理论体系,治疗时立根于恢复系统的开放性和有序性,本文以SAPHO的病机和治法为例进行重点讨论,以期对复杂系统疾病的诊疗提供新的思路和方法。

玄府郁闭,熵增失序是多系统复杂疾病的根本病机

“熵”是物理学中用于描述系统无序程度的重要参量^[5]。根据热力学第二定律:一个孤立系统中的熵总是在不可逆地增加,直至熵极大的热力学平衡。这里的平衡是极度无序状态,在生物学上意味着死亡。普利高津提出了“耗散结构”理论,认为只有开放系统才能打破热力学的熵增定律,使系统维持有序稳定,称之为耗散导致有序^[6],这与中医理论对生命的认识极为一致。

1. 开放是有序之基 开放性是生命的首要条件。数十亿年的演化形成了目前高度有组织、有秩序的生命系统,通过与外界环境的物质、能量差维持自身的非热力学平衡稳态,此特有的负熵化机制使生命得以延续,薛定谔将其总结为“生命以负熵为食”。如果生命变成孤立或封闭系统,与环境的物质、能量交换的途径就会被终止,新陈代谢就会随之停止,生命系统也将土崩瓦解^[5]。

开放是生命有序性的基础。中医学很早就意识到人生存之本在于与自然相通相应,如《素问·宝命全形论》言:“人以天地之气生,四时之法成”,并建立了气化学说,以气的“出、入”运动来描述人体的开放性,并以“升、降”来论述体内能量代谢的有序性,故《素问·六微旨大论》有云:“出入废,则神机化灭;升降息,则气立孤危。故非出入,则无以生长壮老已;非升降,则无以生长化收藏”。中医学以“气化学说”建立起复杂有序的生命观,并用以阐释人体的生命活动、生理功能、病理变化以及生命消亡^[7]。

2. 玄府开阖决定系统的开放性 机体气化机制依赖于其“门户”——玄府的控制,玄府的开阖有度是生命系统维系有序稳定的关键^[8]。《素问·水热穴论》首次提出了“玄府”概念,把玄府定义为汗孔,曰:“所谓玄府者,汗空也”。金代时期,刘完素进一步丰富了玄府的内涵,提出玄府即“门户”,其著作《素问玄机原病式》曰:“然玄府者,无物不有,人之脏腑、皮毛、肌肉、筋膜、爪牙,至于世之万物,尽皆有之,乃气出入升降之道路门户也”,认为玄府是极其细微的空隙,彼此相连,具有广泛性与开放性,内可达五脏六腑,外连四肢百骸及发肤皮毛,将机体内外连接成一个功用相依的有机性整体^[9]。从此,玄府的概念被后世医家所重视,明代楼英《医学纲目》云:“目盲耳聋,鼻不闻臭,舌不知味,手足不能运用者,皆由玄府闭塞,而神气出入升降之道路不通利”。可见,广义的玄府遍布周身内外,其开阖启闭决定气机升降、气血津液运行、神机运转,是维持生命系统开放性的关键,玄府病变,可害百病。

3. 玄府郁闭,积熵为病 玄府的生理特性是贵开忌闭,以开为顺,闭为逆^[10],开阖有度乃为常理。机体需要不断以玄府为通道,通过气化作用进行物质、能量的摄入与耗散,抵消系统内不可逆的熵增,维持机体总熵的负值状态。玄府密闭,相当于生命系统与外界的沟通交互的门户关闭,系统的开放性下降,排熵不畅,积滞而为病。正如刘完素《素问玄机原病式》中所说:“有所闭塞者,不能为用也,若目无所见,耳无所闻,鼻不闻臭,舌不知味……悉由热气怫郁,玄府闭塞而致气液、血脉、荣卫,精神不能升降出入故也”。一旦玄府开阖失司,机体表现为气化失司,当人体负熵化机制和过程失常,内熵积滞,机体的有序度将下降,平衡稳态打破,即进入熵病态^[5]。

熵病以热熵积滞为特点,表现为糖、脂和蛋白质的能量代谢异常,产热过多而散热受阻,积滞于内,产生局部红、肿、热、痛的实热症状,或者全身发热、闭塞不通;进一步发展会引起机体的有序度下降,津停为饮,血滞为瘀,以致器质结构的破坏,多系统继发表现出病理改变,影响机体神经、内分泌、免疫功能,生命活动呈现多层次的失序状态^[8]。

SAPHO综合征的系统中医病机特点

人体是一个由元整体分化而成的有机体^[11],皮、肉、筋、脉、骨五体虽各自为用,但从现代医学而言,皆由受精卵分化而成,其生理、病理亦紧密相连,在

表以皮部御外邪而应天地之变,内里以肉、筋、骨为主干,支撑人体形体运动,中以血脉相连,滋润濡养。作为功能联系的整体,若有病患,必内外相扰,相结为病。玄府遍布五体,是其生理联系的通道门户,也是病理相关的根结所在。一旦皮肤、筋骨、络脉的玄府郁闭,机体的开放性下降,必会导致内熵积滞而为病,这是SAPHO综合征的关键病机。

1. 玄府密闭,系统开放性下降 皮肤是人体与外界相连最为密切的组织器官,为人体屏障,更是决定系统开放性的关键。现代生理学认为,皮肤的屏障功能是防御外界物化因素损伤和微生物侵害的关键,皮肤正常的含水量对维持皮肤屏障的防御功能非常重要^[12]。银屑样皮损是SAPHO综合征的常见皮肤症状^[13],以皮肤水分丢失、慢性角化、红斑、干燥脱屑为主要表现,可见表皮组织角质层明显增厚、排列紧密、棘层肥厚水肿^[14]等密闭不通之象。《金匱要略·脏腑经络先后病脉证》云:“腠者,是三焦通会元真之处,为血气所注;理者,是皮肤脏腑之文理也”,在中医理论中皮肤气血的循行、津液的布散是玄府的主要功能,狭义玄府一词特指皮下汗孔,《类经十三卷·疾病类五》言:“气门,玄府也,所以通行营卫之气,故曰气门”,作为营卫之气运行的通道,通过其开阖启闭,调控气机的出入与津液的排泄,维持皮肤的正常屏障功能。一旦玄府郁闭,气津不布,肌肤不荣,则易干燥脱屑为病。

SAPHO综合征的另一重要表现就是骨和关节的病变,多集中于锁骨、胸骨、脊椎骨,常以弥漫性骨质疏松硬化和骨皮质增生、肥厚为主,累及相邻关节,引起韧带钙化,关节腔的狭窄,发展成为骨关节炎^[15];也有见溶骨性病变,影像学检查见低密度的骨质破坏^[16]。人体骨骼由外部致密的骨皮质和内部结构疏松的骨松质构成,被覆纤维结缔组织的骨膜,以滋润营养骨骼。现代解剖学发现,骨骼并非实性结构,在骨皮质内存在如骨小梁、伏克曼管、哈弗氏系统管道等微观空腔间隙结构,这些腔隙中走行血管和神经,与内外相通,为骨骼的生理功能提供营养血液和必须的代谢物质,这些腔隙结构也应与中医的玄府属于相同的概念范畴^[17],其分布、空隙的大小都对维持骨骼的生理代谢、韧性、骨折修复至关重要。玄府开阖失司,气血津液不布,骨骼失养而增生肥厚;骨髓玄府密闭而络脉不利,腔髓不充,则筋骨不坚。

《灵枢·小针解》曰:“络脉之渗灌诸节者也”,络脉是气血运行的通道,通达内外,滋润濡养,其通畅滑利可以保障皮肤的弹性、骨骼的坚韧和关节的滑利。玄府之于络脉,相当于其与周围组织进行物质交换的“门户”,两者共同构成“玄府-络脉”系统:络脉滋养玄府维系其开阖启闭功能,玄府决定络脉的通利舒畅,两者相互为用^[18-19],一旦玄府郁闭,络脉不畅,血运缓而凝集成瘀,周围组织继而失养为患。可见,在SAPHO综合征中皮-脉-筋骨虽各有病变,究其病机特点具有高度一致性。

2. 玄府密闭,热熵积滞 玄府密闭,热熵积滞是SAPHO综合征的关键病机。SAPHO综合征患者以掌跖脓疱病、重度痤疮为典型皮肤表现,多伴有骨骼的疼痛、压痛、肿胀、发热,以多发性骨髓炎、无菌性骨炎为主^[3],此外,临床病例报道中也见扁桃体炎^[20]、炎性肠病^[13]、胸膜炎和脑膜炎^[21]、大动脉炎^[22]等各系统炎症并发出现,可见,SAPHO综合征虽常见多系统、器官同时受累,病症繁多,但多系统的病理表现皆具有表密而郁热在里的特点。《素问·生气通天论》有云:“劳汗当风,寒薄为皴,郁乃痤”,《素问·调经论》亦云:“玄府不通,卫气不得泄越,故外热”。从人体的整体性出发,可将各种郁热内结的病机归为玄府密闭,热熵积滞,甚则久积酿毒。皮玄府开阖失司,滞于皮肤则见疮痈肿毒;骨玄府密闭失用,则热积不透,则酿毒化腐,各类生物膜、肠及血脉亦是同理。从系统的元整体入手,将SAPHO综合征的病机归为玄府密闭,热熵积滞有利于疾病的宏观把握。

治疗应以透玄排熵以调序为基本大法

玄府以开为用,气机的运行、营血灌注、津液输布,均有赖于玄府通利,是机体排熵的关键通道。由于玄府分布广泛,玄府郁闭可导致机体脏腑经络、四肢百骸、皮肉官窍各个层次的病变,可表现为气血津液、精神荣卫异常等多种形式,复杂多样。SAPHO综合征患者多见皮肤、骨骼、胃肠道等多系统玄府病变,立足于系统的宏观整体,以热熵积滞为病机关键,从透玄排熵入手,打开机体与外界交换之门户,使气机宣通,皮肤毛窍及形体百骸得以津血滋养;热熵耗散通畅,恢复机体原有神机生化之序,对于多系统并现的热熵积滞常见奇效。

临床诊疗中应注重辛味药物的使用。《素问·藏气法时论》云:“辛以润之,开腠理,致津液,通肺

气”。辛者,轻清升浮,能散能行,为“透玄”之要药,外解表邪,内散郁结,以其走窜之力透腠外出,帮助机体恢复其原有序结构。其中以麻黄为透玄排熵第一要药,缪希雍《神农本草经疏》提出:“麻黄,轻可去实,故疗伤寒,为解肌第一”。《日华子本草》亦称麻黄“通九窍,调血脉,开毛孔皮肤,逐风,破癥癖积聚,逐五脏邪气,退热,御山岚瘴气”。可见,麻黄的作用范围远不止肌表,其发散之性可内达脏腑,深入积聚癥瘕。透玄排熵的关键在于恢复有机体的开放性,使气机畅达,恢复机体原有的有序稳定,临床应用不应拘泥于发汗解表。《医学真经》曰:“调气以和血,调血以和气,通也;下逆者使之上行,中结者使之旁达,亦通也;虚则助之使通,寒者温之使通,无非通之法也”。常富业等^[23]提出了开通玄府应包含广义的理气、攻下、活血、凉血、清热解毒、补虚等九大治法,其中配伍辛温走窜之药是组方共性,但临床选择应审时度势,灵活应用。

病案举隅

患者某,男,58岁。2021年7月29日初诊。主诉:双手掌及双足底散在豆大型脓疱疹,胸骨后痛、多关节痛2年余。2019年1月患者于北京某医院皮肤科就诊,结合影像学检查确诊为SAPHO综合征,给予甲氨蝶呤、秋水仙碱、复方甘草酸苷片、柳氮磺吡啶肠溶片口服治疗,症状缓解不明显,治疗2个月后改方案为依托考昔片、雷公藤多苷片、湿热痹颗粒、枸橼酸托法替布片联合治疗,症状稍有缓解。2021年7月患者自觉疼痛无明显诱因加重,为求系统中医诊疗来诊。患者自诉夜间低热2月余,最高温度37.5℃,头晕乏力,头后部见包块硬结,双侧手掌及足底见散在豆大型脓疱和红色皮疹伴脱屑,疱液浑浊,疼痛明显。胸骨后痛,腰膝关节疼痛不适,大便干难排,面色黑,舌黯有裂纹,苔薄黄腻,脉弦滑数。西医诊断:SAPHO综合征。中医诊断:痹证;辨证:玄府密闭,湿热蕴结。治法:透玄清热排熵。予甘露消毒丹加减:桂枝15g,蜜麻黄9g,白蔻仁10g,藿香10g,射干10g,薄荷10g,川木通3g,滑石粉10g,黄芩10g,连翘30g,酒大黄10g,白薇10g,地骨皮15g,石菖蒲10g,白芍15g,天花粉30g。7剂,每日1剂,水煎,早晚分服。

二诊(2021年8月2日):患者自诉服药2剂后低热消退,乏力减轻。手部皮疹瘙痒感缓解,足部仍有脓疱疮,伴明显瘙痒疼痛,肩背疼痛,后头部包块硬

结减少,精神气色佳。舌红,苔薄黄微腻有裂纹,脉沉滑。予甘露消毒丹、麻黄连翘赤小豆汤、麻黄细辛附子汤三方合用加减:原方去天花粉、炒白芍;加制附子10g,细辛6g,赤小豆30g,地肤子30g,白鲜皮30g,醋乳香9g,醋没药9g,丹参15g,赤芍15g,玄参30g,芒硝3g。7剂,日1剂,煎服法同前。

三诊(2021年8月19日):手足皮疹及脓疱基本痊愈,少量脱皮,后头部包块已消,无关节痛。效不更方,守二诊方,每晚1次,两日1剂。后随访,患者已临床治愈,皮疹及脓疱、关节痛等症状未复发。

按:该患者患病2年余,手足疱疹明显,骨关节疼痛,符合SAPHO综合征影像学征象和临床诊断标准。除皮肤与关节症状外,患者另有长期发热,包块硬结的临床症状,皆由玄府郁闭,热熵排出不畅,而积滞化热,继而气阻痰凝,化为局部有形包块,舌脉皆为内郁化热之象。治疗以透玄排熵,恢复人体之序为基本大法,以麻黄、桂枝、白蔻仁、藿香、薄荷、细辛之芳香辛散之品开达全身内外玄府,以大黄、芒硝攻下开玄,配伍乳香、没药、丹参、赤芍、玄参凉血活血开玄,射干、连翘清热解毒透热闭玄府之邪,全方寒热并用,以辛温开玄之力助余药凉血、解毒,通达内外,推陈出新,恢复系统原有的有序稳态结构。

小结

SAPHO综合征表现出皮肤、骨骼等多系统疾病,还原论的诊疗思路往往忽视系统内部的整体联系,针对复杂病机常难以多系统同时获效,中医系统论从人体的元整体出发,重视生命系统的开放性和整体性,认为SAPHO综合征的诸多病症皆由“玄府郁闭,热熵积滞”而生,应以透玄排熵为基本治法,以调整生命有序稳态为治疗之本,临床诊疗切实有效,其诊疗思路亦可延伸于其他多系统的复杂病变。

参 考 文 献

- [1] Firinu D, Garcia-Larsen V, Manconi P E, et al. SAPHO syndrome: Current developments and approaches to clinical treatment. *Curr Rheumatol Rep*, 2016, 18(6):35
- [2] Xu P, Yi G, Li J. SAPHO syndrome. *Rheumatology (Oxford)*, 2022, 61(7):e205-e206
- [3] 孙文婷,寇秋爱. SAPHO综合征19例临床特征分析. *中国全科医学*, 2022, 25(21):2617-2623
- [4] 王哲,李忱,郝伟欣. SAPHO综合征的中医研究进展. *中华中医药杂志*, 2020, 35(3):1384-1386
- [5] 祝世讷,马淑然,黄海量,等. 中医系统论原理. 北京:中国中医

- 药出版社,2021:196-223
- [6] [比]普利高津.复杂性的进化和自然界的定律.西安:陕西科学技术出版社,1982:156
- [7] 郝宇,贺娟.论《内经》气化学说.北京中医药大学学报,2016,39(5):357-359
- [8] 张海蓉,朱佩,孙一珂,等.从玄府为人体耗散结构之基论治痹病.中华中医药杂志,2023,38(3):1061-1064
- [9] 向圣锦,路雪婧,张富文,等.中医玄府理论研究述评.中华中医药杂志,2020,35(8):21-25
- [10] 吕阳婷,张凯歌,曹克刚.基于李士懋“汗法新论”对玄府理论的思考.环球中医药,2021,14(3):421-423
- [11] 孙一珂,刘雷蕾,朱佩,等.从元整体发生学观点探讨“天人相应”的本质内涵.中医学报,2022,37(3):466-470
- [12] Yosipovitch G, Misery L, Proksch E, et al. Skin barrier damage and itch: Review of mechanisms, topical management and future directions. Acta Derm Venereol, 2019, 99(13): 1201-1209
- [13] 杨阳,尹梦蝶,王朝.基于Web of Science数据库SAPHO综合征文献的可视化分析.湖南中医杂志,2022,38(3):116-122
- [14] Skin inflammation associated with arthritis, synovitis and enthesitis. Part 1: Psoriatic arthritis, SAPHO syndrome, Still's disease, Behçet's disease. J Dtsch Dermatol Ges, 2019, 17(4): 472
- [15] Kishimoto M, Taniguchi Y, Tsuji S, et al. SAPHO syndrome and pustulotic arthro-osteitis. Mod Rheumatol, 2022, 32(4): 665-674
- [16] 徐文睿,刘曦,张伟宏. SAPHO综合征骨关节病变的影像学表现. 医学研究杂志, 2021, 50(7): 152-154
- [17] 江花,王明杰,王鸿度.试论“骨玄府”. 中医文献杂志, 2017, 35(1): 6-10
- [18] 张艺馨,张效科.从“玄府-络脉”论治糖尿病周围神经病变. 北京中医药大学学报, 2021, 44(11): 1034-1038
- [19] 孙铭壑,于静,金明秀.基于“玄府-络脉”理论浅谈硬皮病. 环球中医药, 2022, 15(1): 38-41
- [20] 王轶,栾岚,赵杨,等. SAPHO综合征耳鼻咽喉表现的临床研究. 医学研究杂志, 2021, 50(1): 42-46
- [21] 韩昌旭,李渊,王彬. 5例SAPHO综合征的临床特点. 皮肤性病诊疗学杂志, 2021, 28(4): 279-283
- [22] 陆磊,孔令斌,邵莉. 大动脉炎合并SAPHO综合征一例. 中华风湿病学杂志, 2021, 25(4): 253-254
- [23] 常富业,王永炎,高颖,等.论开通玄府. 中国临床康复, 2005, 9(39): 128-129, 132

(收稿日期: 2022年11月28日)

• 临证经验 •

川南玄府学术流派学术思想及临证用药特色

江玉, 江花, 张琼, 白雪, 张德绸

(西南医科大学中西医结合学院·附属中医医院, 泸州 646000)

摘要: 川南玄府学术流派以金元医学大师刘河间的玄府学说为主导思想, 由王明杰、黄淑芬教授创立。主要围绕玄府与风药两个层面开展学术研究, 一是玄府学说为风药的拓展运用提供新的理论指导, 二是风药发散开玄可深化开通玄府治法, 流派在长期探索实践中形成了“论病着眼玄府、临证首重开通; 百病疏风为先, 顽症从风论治”的独特学术思想。临证善用风药、虫药开通玄府治疗脑、心、肾病等, 制定优势病种诊疗方案, 研发特色制剂。七味追风散、天虫定眩饮、蛭龙活血通瘀胶囊等特色方, 凸显了川南玄府学派组方用药的突出特点, 即通过开通脑、心、肾等处玄府闭塞, 畅达气血津液运行以愈诸病。

关键词: 玄府学说; 学术流派; 川南玄府学术流派; 学术思想; 用药特色

Academic thinking and prescription characteristics of southern Sichuan Xuanfu academic school

JIANG Yu, JIANG Hua, ZHANG Qiong, BAI Xue, ZHANG Dechou

(College of Integrated Chinese and Western Medicine, Southwest Medical University, Luzhou 646000, China)

基金资助: 四川省科技计划 (No.2022YFS0613), 四川省中医药管理局项目 (No.2021MS548), 四川省中医药管理局中医药流派工作室项目 (No.川中医药办发〔2019〕37号), 四川省十大名中医王明杰工作室建设项目 (No.川中医药办发〔2019〕38号), 全国名老中医药专家黄淑芬传承工作室建设项目 (No.国中医药人教函〔2018〕134号)

通信作者: 江玉, 四川省泸州市龙马潭区香林路1段1号西南医科大学中西医结合学院·附属中医医院, 邮编: 646000

电话: 0830-3160529, E-mail: jiangyu-22@126.com